

Préparation au concours de résidanat

Année universitaire : 2025-2026

Troubles anxieux

1ère Partie : QCM

1. **L'anxiété est considérée comme pathologique lorsque :**
 - A. Son intensité est excessive par rapport à la situation
 - B. Elle disparaît immédiatement dès que le danger s'éloigne
 - C. Elle comporte un pessimisme
 - D. Elle induit une limitation des activités quotidiennes et sociales
 - E. Elle se manifeste par des inquiétudes passagères
2. **L'attaque de panique qui entre dans le cadre d'un trouble panique**
 - A. Apparaît après 50 ans
 - B. Dure 10 minutes en moyenne
 - C. Est déclenchée par la présence d'une situation objectivement menaçante
 - D. S'accompagne d'une peur intense de mourir
 - E. Survient de manière inopinée
3. **Les symptômes psychiques observés au cours d'une attaque de panique sont :**
 - A. Peur de devenir fou
 - B. Peur d'avoir une maladie grave
 - C. Tachycardie
 - D. Sueurs
 - E. Peur de mourir
4. **Les affections suivantes peuvent donner un tableau clinique évoquant une attaque de panique :**
 - A. Embolie pulmonaire
 - B. Intoxication au CO
 - C. Hypothyroïdie
 - D. Phéochromocytome
 - E. Infarctus de myocarde
5. **Un trouble panique peut se compliquer de :**
 - A. Anxiété anticipatoire
 - B. Agoraphobie
 - C. Dépression
 - D. Abus d'alcool
 - E. Trouble anxiété généralisée
6. **Le trouble anxiété généralisée se caractérise par :**
 - A. L'imagination de " scénarios catastrophes"
 - B. Un évitement social
 - C. Une anxiété anticipatoire
 - D. Une hyperesthésie sensorielle
 - E. Une tendance au pessimisme

- 7. Le tableau clinique de l'anxiété généralisée comporte :**
- A. Des cauchemars
 - B. Des Idées suicidaires
 - C. Une tension motrice
 - D. Une hypersomnie
 - E. Une hyper vigilance
- 8. Dans le cadre des troubles phobiques, l'anxiété :**
- A. Apparaît de façon inopinée
 - B. Entraîne des conduites d'évitement
 - C. Est paroxystique
 - D. Est reconnue comme pathologique par le sujet
 - E. Se manifeste lors de l'anticipation de confrontation à une situation phobogène
- 9. Les deux types de réponses comportementales qui permettent au phobique de se défendre contre l'anxiété sont :**
- A. La réassurance
 - B. La prévention de la réponse
 - C. L'évitement
 - D. L'exposition
 - E. L'inhibition
- 10. Dans les phobies spécifiques, l'anxiété peut concerner les objets ou les situations suivantes :**
- A. Voyager par avion
 - B. Parler à un supérieur
 - C. Etre en hauteur
 - D. Faire une injection
 - E. L'orage
- 11. L'agoraphobie est la peur de :**
- A. Ecrire en public
 - B. Agresser quelqu'un
 - C. Se retrouver dans une foule
 - D. Ne pas être secouru en cas de malaise
 - E. Agir de façon humiliante
- 12. L'anxiété sociale se manifeste dans les situations suivantes :**
- A. Faire un exposé ou une conférence
 - B. Voyager par avion
 - C. Parler à un supérieur
 - D. Faire connaissance avec quelqu'un
 - E. Se retrouver seul dans une file d'attente
- 13. Le tableau clinique du trouble obsessionnel-compulsif peut inclure :**
- A. Des ruminations concernant des événements futurs
 - B. Des pensées intrusives absurdes et inappropriées
 - C. Un sentiment de culpabilité
 - D. Des rituels conjuratoires
 - E. Un évitement efficace sur l'anxiété

- 14. L'obsession est une idée qui s'impose à l'esprit et que l'on peut décrire par les éléments suivants :**
- A. A l'origine d'une lutte anxieuse
 - B. Assiège le fonctionnement mental du sujet
 - C. Imposée par une force extérieure
 - D. Considérée absurde par le sujet
 - E. Etrangère à la volonté du sujet
- 15. Mr A., 24 ans, a peur d'attraper une infection incurable en serrant la main d'un étranger. Il s'agit de :**
- A. Phobie spécifique
 - B. Obsession phobique
 - C. Phobie d'impulsion
 - D. Phobie sociale
 - E. Trouble obsessionnel-compulsif
- 16. Le tableau clinique du trouble stress post traumatique comprend :**
- A. Des expériences de flash-back
 - B. Une hyperréactivité neurovégétative
 - C. Un syndrome d'évitement
 - D. Des hallucinations visuelles
 - E. Un délire onirique
- 17. L'anxiété de séparation se distingue de l'angoisse de séparation normale par :**
- A. Son âge d'apparition précoce
 - B. Son retentissement scolaire important
 - C. La possibilité de son apparition à l'adolescence
 - D. La durée qui dépasse quinze jours
 - E. Sa plus grande fréquence chez les filles
- 18. Les benzodiazépines dans le traitement du trouble panique :**
- A. Peuvent réduire rapidement l'anxiété
 - B. Peuvent induire une dépendance
 - C. Sont utiles pour couvrir le délai d'action des ISRS
 - D. Correspondent au traitement de fond du trouble
 - E. Sont prescrits au long cours
- 19. Les traitements prolongés par les benzodiazépines peuvent provoquer :**
- A. Des troubles du rythme cardiaque
 - B. Une anxiété aigüe
 - C. Une hypersomnie
 - D. Des troubles mnésiques
 - E. Une dépendance physique
- 20. Les thérapeutiques possibles des troubles anxieux comportent :**
- A. Les thérapies cognitivo-comportementales
 - B. Les anxiolytiques
 - C. Les neuroleptiques
 - D. Les thymorégulateurs
 - E. Les antidépresseurs

1^{ème} Partie : Cas cliniques

Cas clinique (1)

Mlle F., 21 ans, consulte aux urgences pour difficultés respiratoires. L'examen clinique trouve une patiente instable, essoufflée, tremblante. Elle répétait que les sons paraissaient lointains et étouffés, qu'elle avait peur de mourir. L'examen somatique est normal.

Mlle F. est accompagnée par ses parents qui assurent qu'elle était bien portante il y a une heure, qu'elle ne prend aucun médicament et ne consomme aucune substance. Ils vous informent aussi qu'elle a présenté deux épisodes similaires durant ce dernier mois et que depuis elle a tellement peur de revivre la même chose qu'elle a arrêté de faire du sport.

Mlle F., est étudiante et serait actuellement en période de préparation des examens de fin d'année.

1. Le tableau clinique présenté par Mlle F. comporte :

- a) Une anxiété anticipatoire
- b) Une déréalisation
- c) Une nosophobie
- d) Un catastrophisme
- e) Un évitement

2. Devant ce tableau clinique, on évoque :

- a) L'agoraphobie
- b) La phobie sociale
- c) Le trouble anxiété généralisée
- d) Le trouble panique
- e) L'hypochondrie

3. Pour votre diagnostic retenu, quel serait le traitement le plus approprié :

- a) Paroxétine 20 mg/j
- b) Olanzapine 10mg/j
- c) Diazépam 15mg/j
- d) Carbamazépine 800mg/j
- e) Halopéridol 10mg/j

4. En plus du traitement médicamenteux, les techniques thérapeutiques qui seront bénéfiques à cette patiente sont :

- a) La respiration abdominale
- b) La relaxation
- c) La thérapie familiale
- d) La stimulation magnétique transcranienne
- e) La thérapie comportementale et cognitive

Cas clinique (2)

Mme Amal, 35 ans, vous consulte pour céphalées et asthénie évoluant depuis plusieurs mois. Elle se sent tendue, a du mal à trouver le sommeil et se fatigue rapidement. Elle se plaint de troubles de la mémoire et vous dit qu'elle perd souvent ses affaires personnelles. Elle a consulté plusieurs médecins mais elle garde les mêmes symptômes qui la gênent au quotidien.

Elle reconnaît être de nature inquiète. Elle s'inquiète pour l'état de santé de ses parents. Elle s'affole quand le téléphone sonne le soir ou tôt le matin. Elle se demande toujours si elle fait assez pour ses enfants. Elle n'arrête pas de penser à ce que son patron pourrait penser d'elle et se demande tout le temps si elle a oublié quelque chose d'important.

1. **Les signes psychiques mis en évidence dans cette observation sont :**
 - a) Des obsessions
 - b) Une anhédonie
 - c) Une anxiété anticipatoire
 - d) Une anxiété de performance
 - e) Un catastrophisme
2. **Devant ce tableau clinique, le diagnostic le plus probable est :**
 - a) Un trouble obsessionnel compulsif
 - b) Un trouble dépressif caractérisé
 - c) Un trouble anxiété généralisée
 - d) Un trouble anxiété sociale
 - e) Une personnalité anxieuse
3. **Quelle est la prise en charge initiale appropriée ?**
 - a) Antidépresseurs tricycliques
 - b) Antidépresseurs ISRS
 - c) Anxiolytiques benzodiazépines
 - d) Electro-convulsivothérapie
 - e) Sels de lithium
4. **La prise en charge comportementale et cognitive chez cette patiente vise à :**
 - a) Eviter les situations stressantes pour limiter l'anxiété
 - b) Identifier les interprétations catastrophiques et les modifier
 - c) Supprimer toute inquiétude
 - d) Encourager les ruminations pour mieux comprendre l'anxiété
 - e) Identifier les symptômes physiques et prescrire des myorelaxants

Cas Clinique (3)

Mr S., 34 ans, vous consulte pour tristesse et insomnie. Il se décrit comme réservé, timide et ayant peu d'amis. Il dit qu'il n'est pas épanoui dans son travail actuel. Lors des réunions, à chaque fois où il doit faire part aux discussions, il a des palpitations, une sensation d'oppression thoracique et une peur de perdre connaissance. Il craint de paraître maladroit et ridicule et ces craintes l'empêchent d'aller vers les gens et établir des relations amicales.

1. **Les signes psychiatriques mis en évidence dans cette observation sont :**
 - a) Des obsessions
 - b) Une anhédonie
 - c) Une anxiété anticipatoire
 - d) Une anxiété de performance
 - e) Un catastrophisme
2. **Les situations redoutées par Mr S. comportent :**
 - a) La possibilité d'un oubli
 - b) Les activités observées
 - c) Les décisions à prendre au travail
 - d) Les interactions sociales quotidiennes
 - e) Les prises de parole en public

3. **Les comportements utilisés par Mr S. dans les situations stressantes sont :**
 - b) L'évitement
 - c) L'exposition
 - d) L'anticipation
 - e) L'excitation
 - f) La recherche de réassurance
4. **Le traitement de fond utilisé pour dans ce cas comporte :**
 - a. Des antidépresseurs ISRS
 - b. Des anxiolytiques
 - c. Une thérapie comportementale et cognitive
 - d. Des antidépresseurs tricycliques
 - e. Des bêtabloquants

Cas Clinique (4)

Vous recevez en consultation Mr M.D., 34 ans, informaticien, qui consulte à la demande de sa mère qui s'inquiète à propos de « ses habitudes ». En effet, il doit vérifier trois fois chaque interrupteur électrique et l'arrivée de gaz car il craint qu'ils ne restent ouverts et qu'il ne provoque un accident. Il soulage plusieurs fois les mains et ça peut durer des heures pour soulager son esprit qui est envahi par la pensée de microbes sur ses mains. Il vous explique qu'il a choisi de travailler de chez lui car à chaque fois qu'il prend la voiture il craint qu'il a poussé un piéton sous les roues d'une voiture. Pour soulager cette pensée déraisonnable (comme lui-même le concède) il a l'habitude de compte à rebours à partir de 33 tout en alternant des mouvements de la main droite.

1. **Les inquiétudes de Mr M.D. :**
 - a) Concernent des événements hypothétiques du quotidien
 - b) Sont faciles à contrôler
 - c) Imprègnent son fonctionnement psychique
 - d) Sont responsables d'une lutte anxieuse
 - e) Sont reconnues comme absurdes
2. **La crainte angoissante de contracter des microbes est une :**
 - A. Obsession phobique
 - B. Nosophobie
 - C. Phobie spécifique
 - D. Obsession idéative
 - E. Une conduite d'évitement
3. **Le fait de compter à rebours décrit dans l'observation correspond à :**
 - a) Une compulsion
 - b) Une rumination
 - c) Un évitement
 - d) Une soliloquie
 - e) Un automatisme mental

Cas Clinique (5)

Lina, 9 ans, refuse de se rendre à l'école depuis trois mois, prétextant à chaque fois des maux de ventre et des maux de tête. A l'entretien, elle vous dit qu'elle s'inquiète constamment pour sa maman, affirme que quelque chose de mal va lui arriver si elle s'éloigne d'elle. La mère rapporte aussi que Lina refuse désormais de dormir seule dans sa chambre, qu'elle présente des cauchemars récurrents où sa mère disparaît.

1. Parmi les éléments suivants lesquels suggèrent plutôt une anxiété de séparation pathologique plutôt qu'une anxiété normale ?

- A. Cauchemars répétés concernant la séparation
- B. Disparition rapide de l'anxiété une fois avec ses camarades
- C. Peur intense et récurrente difficile à apaiser même en présence du parent
- D. Préoccupations diffuses concernant la santé ou les catastrophes
- E. Symptômes somatiques fréquents liés à la séparation

2. Les stratégies thérapeutiques recommandées pour l'anxiété de séparation sont :

- A. Thérapie cognitivo-comportementale avec exposition graduée à la séparation
- B. Isolement progressif de l'enfant pour l'habituer à rester seul
- C. Renforcement positif et encouragement progressif à l'autonomie
- D. Prescription de benzodiazépines
- E. Intervention éducative et collaboration avec les enseignants